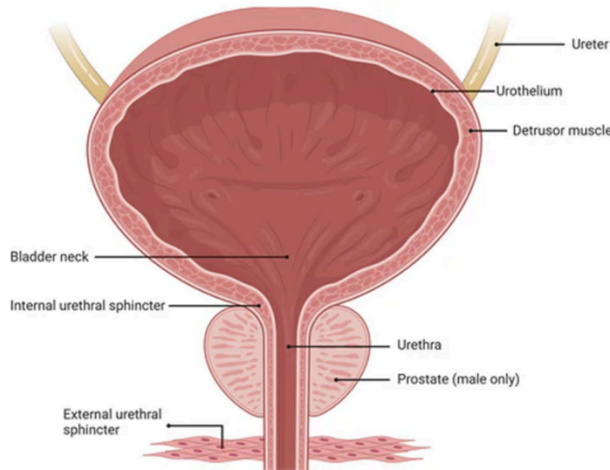
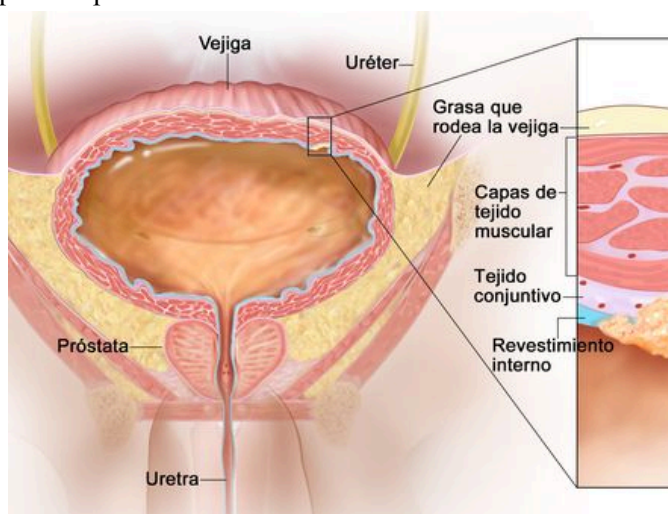




NOMBRE DEL ESTUDIANTE:		CÓDIGO:	NIVEL DE PRÁCTICA:
NOMBRE DEL DOCENTE : Samuel Palacio Peña		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD: Urología	CIRUJANO:	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO A REALIZAR: <i>CISTOPEXIA</i>			
PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA			
• ETAPA DE PLANEACIÓN:			
1.1. OBJETIVO QUIRÚRGICO: (HACER DESCRIPCIÓN) El objetivo quirúrgico es realizar la colocación de una cinta de malla sintética debajo de la uretra para proporcionar soporte adicional y prevenir la pérdida de orina.			
1.2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA: (HACER GRÁFICO Y DESCRIPCIÓN). ANATOMÍA  The diagram illustrates the male urinary system. At the top, two yellow tubes represent the ureters entering the bladder. The bladder is a large, sac-like organ with a textured interior. Labels point to the 'Ureter', 'Urothelium' (inner lining), and 'Detrusor muscle' (the muscular wall of the bladder). The 'Bladder neck' is the lower part of the bladder. Below it is the 'Internal urethral sphincter'. The 'Urethra' is the tube that carries urine from the bladder. The 'Prostate (male only)' is shown as a gland through which the urethra passes. At the bottom, the 'External urethral sphincter' is shown as a voluntary muscle that can contract to stop urine flow.			
La vejiga es un órgano muscular hueco y distensible, situado en la cavidad pelviana, por detrás de la sínfisis del pubis. En los hombres, se encuentra por delante del recto y en la mujer es anterior a la vagina e inferior al útero. Con una capacidad de la vejiga oscila en promedio entre 700 y 800 ML.			
La vejiga posee 3 porciones:			

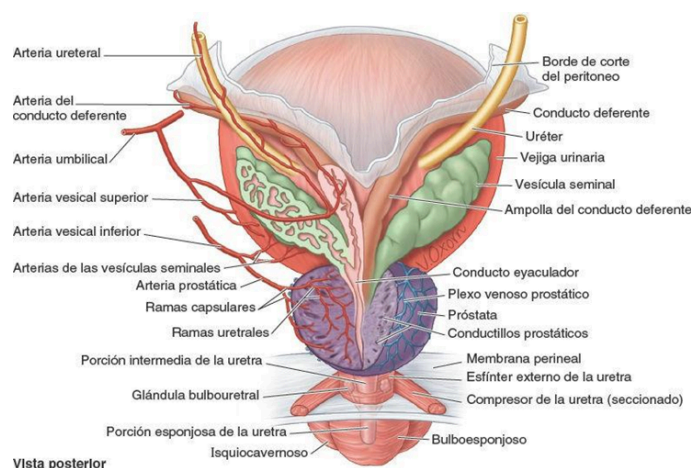
- o **Cuerpo:** Dónde la orina es recolectada.
- o **Fondo (Base):** Contiene al trigono vesical.
- o **Trígono Vesical:** Donde se localiza la uretra.

A su vez se compone por 3 capas:



- **Capa Serosa:** Se compone de tejido conectivo alveolar.
- **Capa Muscular:** Formada por 3 capas de fibras musculares lisas: Longitudinal interna, circular media, longitudinal externa.
- **Capa Mucosa:** Compuesta por epitelio de transición y una lámina propia subyacente.

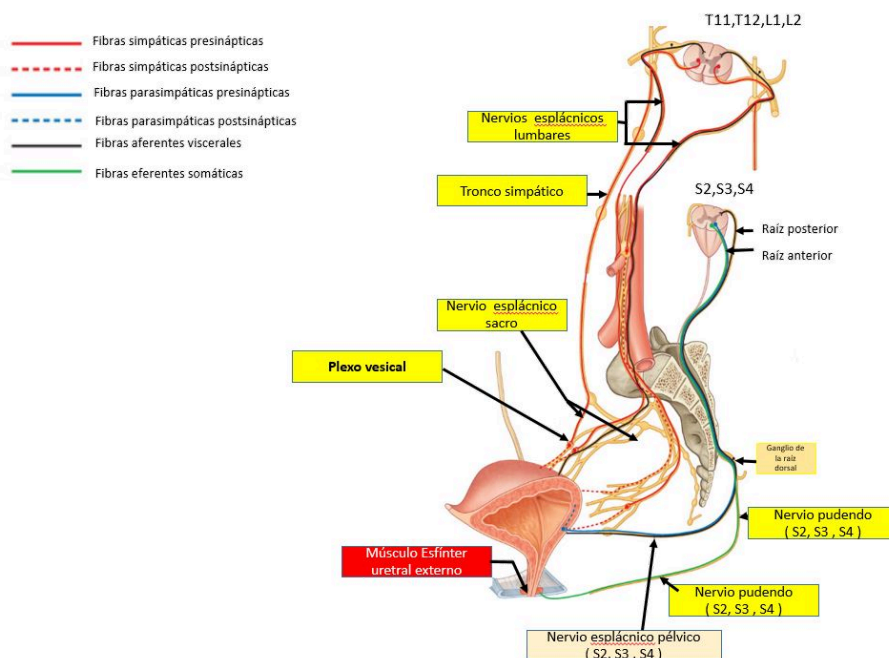
IRRIGACIÓN.



Es drenada por las **venas ilíacas internas**, y tanto en hombres como en mujeres, los vasos linfáticos de las caras supero laterales de la vejiga desembocan en los **ganglios linfáticos ilíacos externos**

INERVACION

Involucra el sistema nervioso simpático y parasimpático



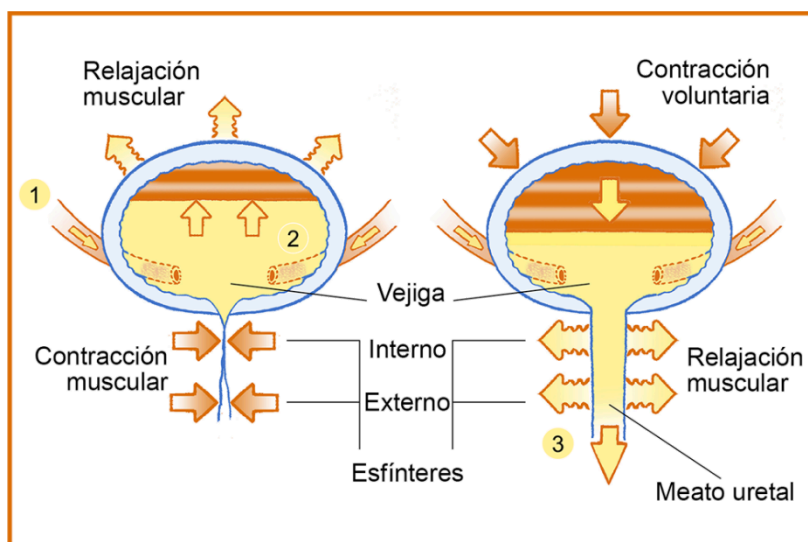
1. Las fibras simpáticas presinápticas para la vejiga urinaria son conducidas desde los niveles torácicos inferiores y lumbares superiores de la médula espinal a través de los nervios espláncnicos lumbares pasando por el tronco simpático lumbar, plexo hipogástrico superior y nervios hipogástricos hacia los plexos vesicales (pélvicos). Es un subplexo del plexo hipogástrico inferior, de ahí envían fibras autónomas postsinápticas a las paredes de la vejiga urinaria.
2. Las fibras parasimpáticas presinápticas para la vejiga urinaria se originan en las neuronas de los segmentos sacros de la médula espinal S2-S4 y pasan desde los ramos anteriores de los nervios espinales sacros, a través de los nervios espláncnicos pélvicos y los plexos hipogástricos inferiores, hasta la vejiga urinaria.

RELACIONES DE LA VEJIGA:

- **PARTE ANTERIOR:**
 - Sínfisis del pubis
 - Espacio prevesical de Retzius.
 - Músculos de la pared abdominal
 - Fascia umbilicoprevesical
 - Uraco

- Vasos umbilicales obliterados
- **PARTE INFERIOR:**
 - Músculo elevador del ano
 - Músculos internos de la pelvis
- **PARTE POSTERIOR:**
 - Tiene el fondo de saco vésico rectal de Douglas y la Ampolla rectal.
- **PARTE SUPERIOR:**
 - Uréteres, Conductos Deferentes y Vesículas Seminales.

FISIOLOGIA



Los músculos de la vejiga que permiten el control voluntario de la micción y permiten 2 funciones: 1) la sensación que permite que reconozcas que tu vejiga está llena y debe ser vaciada y 2) el control motor que permite que puedas orinar voluntariamente.

Primero, como la pared vesical se estira cuando está llena o próxima a su máxima capacidad, existen señales que son transmitidas a través del sistema nervioso parasimpático para contraer el músculo detrusor, el cual es una capa de la pared vesical constituida por fibras de músculo liso que son ordenadas en fascículos longitudinales, circulares o en espiral, esta señal estimulará a la vejiga para expulsar orina a través de la uretra, luego, estas sensaciones dentro de la vejiga serán transmitidas al sistema nervioso central (SNC) por medio de fibras aferentes viscerales generales (AVG). Mientras las fibras aferentes en la cara superior de la vejiga siguen el curso de los nervios simpáticos eferentes hasta el SNC, las fibras aferentes en la porción inferior siguen a las fibras parasimpáticas eferentes.



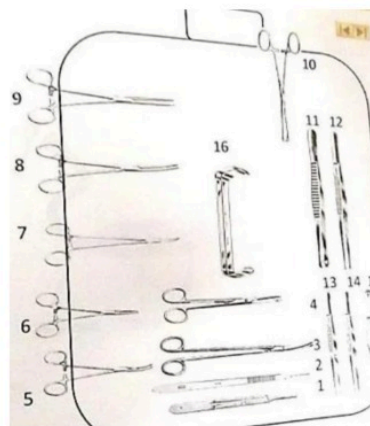
1.3. LISTA DE CHEQUEO:

INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS	FARMACOS Y SOLUCIONES
o Equipo general	- Paquete de ropa - Sonda Foley 16-18 - Jeringa de 10 cc - Gasas - Caucho de succión - Asepto jeringa - Torundas - Hoja de bisturí 15- 20 - Lapicero de electrobisturí - Guantes - Cistofló	PIEL: Polipropileno 3/0 aguja curva cortante $\frac{3}{8}$ de circulo FASCIA: Poliglactin 0 o 1 aguja curva redonda de $\frac{1}{2}$ de circulo SUSPENSIÓN DE LA VEJIGA: Polipropileno 1 aguja redonda de $\frac{1}{2}$ circulo	Solución salina Lidocaina al 1%, 5cc

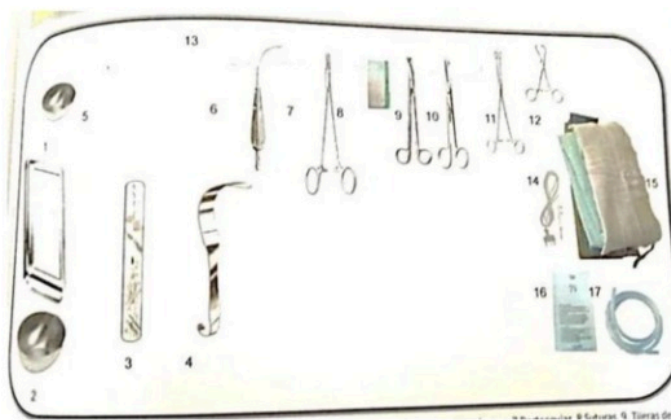
• ETAPA DE ORGANIZACIÓN:

o ARREGLOS DE MESAS DE MAYO Y RESERVA (REALIZAR ESQUEMA).

1. Mango de bisturí 3 largo – hoja 15
2. Mango de bisturí 4 hoja 20
3. Tijeras de Metzembraum
4. Tijeras de mayo rectas
5. Pinzas Kelly curva
6. Pinzas Kelly recta
7. Pinzas Kelly Adson
8. Pinzas Rochester curva
9. Pinza Rochester recta
10. Pinzas Allixss
11. Pinza de disección rusa
12. Pinza disección sin garra larga
13. Pinza disección con garra larga
14. Pinza disección sin garra corta
15. Disección Adson con garra
16. Separadores de Farabeuf



1. Equipo general
2. Coca
3. Valva maleable
4. Deaver angosto
5. Conca con suero
6. Cánula de yankawer
7. Portaagujas
8. Suturas
9. Tijeras de Metzenbaum fina larga
10. Tijeras de mayo largas
11. Pinza Foerster
12. Pinza Backhaus o campo
13. Compresas
14. Lapicero de electrobisturí
15. Paquete de ropa
16. Guantes
17. Caucho de succión

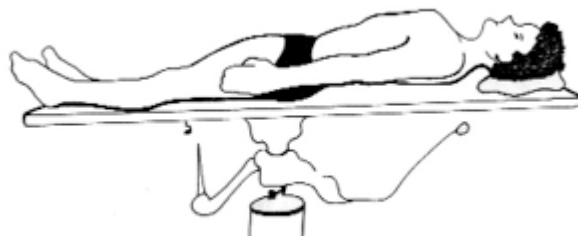


2.2. POSICIÓN DEL PACIENTE (NOMBRE Y GRÁFICO):

Posición de Litotomía



o Decúbito supino



POSICIÓN DE DECÚBITO SUPINO

2.3. UBICACIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO (REALIZAR GRÁFICO):





• **ETAPA DE EJECUCION:**

- **ANESTESIA (ESCRIBIR EL TIPO DE ANESTESIA):** Anestesia general



- **INCISIÓN (ESCRIBIR EL TIPO DE ABORDAJE Y EL NOMBRE DE LA INCISIÓN):**

La incisión es una Pfannenstiel , aunque dependiendo de la técnica (abierta, laparoscópica o con malla)

PROCESO QUIRÚRGICO (DESCRIBIR LOS PASOS PRINCIPALES DE LA TÉCNICA MÉDICO QUIRÚRGICA CON EL INSTRUMENTAL A USAR).

TÉCNICA QUIRÚRGICA	INSTRUMENTACIÓN
Incisión abdominal Pfannestiel.	mango de bisturí 4 hoja de bisturí 20
Visualización de la aponeurosis de los músculos rectos anteriores.	separadores de Farabeuf electrobisturí
Toma de la aponeurosis de los músculos rectos.	Pinza de Allix
Ampliación de la aponeurosis.	Tijeras de Metzembraum Lapicero del electrobisturí



TÉCNICA BURSH: Se llega a peritoneo parietal; se rechaza y se ubican los separadores con el fin de visualizar mejor la vejiga.	Separador abdominal de Balfour, O'sullivan, O'connor o Deaver angosto y valva maleable ancha. Compresas abdominales húmedas
Se ingresa al espacio de Retz us por medio de disección roma con el fin de exponer los espacios paravesicales y la pared vaginal anterior.	Pinza Rochester recta Torunda mediana húmeda
Se expone el ligamento de Cooper separándolo de la sínfisis posterior.	Pinza de disección sin garra Tijera de Metzembraum
Con dos dedos en la vagina el cirujano empuja la pared vaginal hacia ambos lados en dirección al ligamento. Se disea por la parte abdominal la pared vaginal.	Pinza Rochester recta Torunda mediana húmeda
El cirujano extrae la mano de la vagina, se cambia de guante; ya que esta zona se considera contaminada.	Guante
Después de cambiarse el guante procede a anudar los puntos; la uretra y el cuello deben apoyar cómodamente contra el ligamento; aquí el cirujano tiene en cuenta cuanta suspensión ha de hacerse para que la paciente no quede demasiado continente.	Poliéster 0 aguja 1/2 círculo redonda. Polipropileno 0 aguja 1/2 círculo redonda.
Se cortan los puntos un poco largos (1 cm)	Tijera de mayo



Se lava la cavidad abdominal y se retiran los separadores abdominales.	Coca Cánula de Yankawer Pera Caucho de succión Solución fisiológica tibia y agua
Se revisa hemostasia y se realiza el recuento de compresas.	Lapicero de electrobisturí Pinza Foerster
Se visualiza y se sutura la aponeurosis de los músculos rectos anteriores.	Separador de Farabeuf Pinza de disección con garra Portaagujas mediano Tijera de Mayo recta Poliglactín 910 0 aguja 1/2 círculo grande redonda
Lavado del tejido graso.	Coca Suero fisiológico
Revisión de hemostasia del tejido graso.	Lapicero de electrobisturí
Sutura de piel.	Pinza de disección con garra Portaagujas pequeño Tijera de mayo Poliamida o polipropileno 2/0 o 3/0 aguja 3/8 círculo cortante
Curación.	Apósito



**Universidad
de Santander**
Personería Jur. 810 de 12/03/96 Min.Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN **UDES**

**PLANEAMIENTO QUIRURGICO PRACTICA
FORMATIVA
IQX-FT-003-BUC**

Versión: 01

***FORMATO DE INFORME SEMANAL DE LA PRACTICA FORMATIVA
FORMATO RECORD DE ASISTENCIA A CIRUGIA - PRACTICA FORMATIVA
IQX-FT-024-UDES***